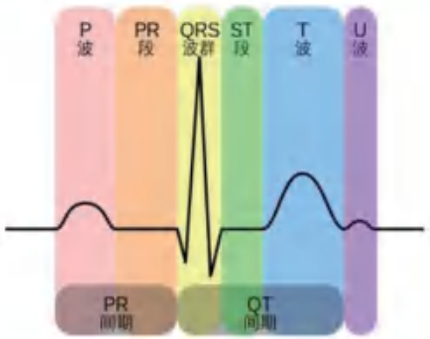


内科含诊断心律失常 ★★★（1~3 题）

心率和心律

- RR 间距＜ 3 个大格（心室率＞ 100）、RR 间距＞ 5 个大格（心室率＜ 60）“小三大五”
- 房颤：RR 间距绝对不等（心律绝对不规则）

P 波

- 窦性 P 波：II 导联直立、aVR 导联倒置
- 房早：提早出现 P′波
  交界早“双向奔赴”：逆行 P′波（可在提早出现的 QRS 波前、中、后）
  阵发性室上速：逆行 P′波或无 P 波（2018）
- 房扑：规则 F 波、固定比或不固定比下传（2018）
  房颤：不规则 f 波（350~600 次 / 分）、不固定比下传（2019）
- 右心房大：肺型 / 高尖 P 波（≥ 0.25mV）
  左心房大：二尖瓣型 / 双峰 P 波（＞ 0.12s）
- 窦性停搏：长 PP 间距与正常 PP 间距无倍数关系
  二度 II 型窦房阻滞：长 PP 间距与正常 PP 间距有倍数关系

QRS 波

- 宽大畸形（≥ 0.12s）
  - 预激综合征：起始部粗钝（δ 波）、后 ST-T 继发性改变（2021、2026）（但顺向型房室折返性心动过速 QRS 波多正常）
  - 室早：提早出现宽大畸形 QRS 波、前无 P 波、后 ST-T 继发性改变、完全性代偿间隙“前无 P 后倒 T”
  - 室速（连续≥ 3 个室早）——特征：心室夺获、室性融合波
  - 室性逸搏及逸搏心律
  - 室内差异性传导
  - 完全变形：室扑（正弦波）、室颤
- 高大 QRS 波
  - 右心室大：RV1+SV5 ≥ 1.05mV、电轴右偏、顺钟向转位（V5 R/S ≤ 1）
  - 左心室大：RV5+SV1 ≥ 4/3.5mV、电轴左偏、ST 段可压低
- M 型 QRS 波
  - 右束支阻滞：V1、V2 导联（常见）
  - 左束支阻滞：V5、V6 导联
- 病理 Q
  - 急性 ST 段抬高型心梗、急性心肌炎、扩张型心肌病、肥厚型心肌病等